

Dzieci w cieniu picia

Dziecko w domu z uzależnieniem uczy się przetrwania, nie życia. Czego konkretnie się uczy, co je rani — i co realnie chroni, nawet gdy uzależniony rodzic się nie leczy.

CZAS: 15 min Dla rodzica nieuzależnionego i opiekunów

ŹRÓDŁO: Felitti i wsp. (1998); Werner & Smith (2001); Jurkovic (2014)

JAK UŻYWAĆ

Sekcja 01 — **cztery rzeczy, których dziecko uczy się w domu z uzależnieniem**. Sekcja 02 — sygnały, które wymagają interwencji. Sekcja 03 — **czynniki ochronne**. Sekcja 04 — plan dla rodzica nieuzależnionego.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Alkoholizm rodzica jest jednym z dziesięciu *niekorzystnych doświadczeń dzieciństwa* (ACE, Felitti, 1998). Dzieci alkoholików mają **4x wyższe ryzyko** własnego AUD i 2-3x wyższe ryzyko depresji i lęku w dorosłości. Werner & Smith (2001, 40 lat obserwacji, N=698): **najsilniejszym czynnikiem ochronnym** jest *bezpieczna relacja z co najmniej jednym dorosłym* — niekoniecznie rodzicem. Drugi co do siły to **stabilna rutyna**. Te dwa czynniki realnie zmieniają trajektorię — niezależnie od tego, czy uzależniony rodzic podejmie leczenie.

01 Czego dziecko uczy się w domu z uzależnieniem

HIPERCZUJNOŚĆ

Nigdy nie wiadomo, co zastanie w domu — trzeźwy rodzic czy pijany, miły czy agresywny. Dziecko **nasłuchuje** kroków, oddechu, tonu. Mózg uczy się stałej gotowości — w dorosłości daje przewlekły lęk.

PARENTYFIKACJA

Dziecko przejmuje rolę dorosłego: opiekuje się rodzeństwem, uspokaja kłótnie, czasem opiekuje się *pijącym rodzicem*. Traci dzieciństwo. W dorosłości — nadmierna odpowiedzialność.

LOJALNOŚĆ DO BÓLU

„O domu się nie mówi”. Dziecko uczy się ukrywać przed nauczycielami, sąsiadami, krewnymi. „*U nas jest OK*”, nawet gdy nie jest. Kosztuje kontaktu z własnym doświadczeniem.

WSTYD ZAMIAST SMUTKU

Zamiast „*tata pije*” przychodzi „*jestem dzieckiem alkoholika*”. Tożsamość zaczyna się wokół tego, co dzieje się w domu. W szkole — ucieczka w rolę: bohater, klaun, niewidoczne dziecko.

02 Sygnały, które wymagają interwencji

Większość dzieci alkoholików nie wymaga natychmiastowej interwencji służb. Niektóre — wymagają. Pięć sygnałów, których nie wolno przegapić.

Przemoc fizyczna wobec dziecka — siniaki w nietypowych miejscach, lęk przy dotyku, urazy wymagające leczenia.

Zaniedbanie — brak jedzenia, brudna odzież, nieleczone choroby, nieobecność w szkole, dziecko same na noc.

Boi się wracać do domu — wprost lub przez zachowanie (przedłuża się w szkole, szuka miejsc u koleżanek).

Samouszkodzanie, myśli samobójcze, używanie substancji u dziecka lub nastolatka.

Świadek przemocy między rodzicami — nawet bez przemocy wobec dziecka. Świadczenie ma te same skutki *neurorozwojowe* co bezpośrednie doświadczenie.

W Polsce: **Niebieska Linia** (800 120 002, 24/7), OPS (Niebieska Karta), **Telefon Zaufania dla Dzieci 116 111**. Pediatria, pedagog, kurator — wszyscy mają możliwość uruchomienia procedury.

03 Co realnie chroni — cztery czynniki z badań

To, że uzależnienie rodzica zwiększa ryzyko, nie znaczy, że dziecko jest skazane. *Werner & Smith* (2001, 40-letnie badanie podłużne) zidentyfikowali cztery czynniki ochronne, które najsilniej zmieniają trajektorię. Każdy z nich jest *w zasięgu działania* rodzica nieuzależnionego, opiekuna lub zaangażowanego dorosłego.

JEDEN BEZPIECZNY DOROSŁY

Stała, ciepła, przewidywalna relacja z *co najmniej jednym* dorosłym. Niekoniecznie rodzic — babcia, ciotka, nauczyciel, trener, terapeuta. To pojedynczy najsilniejszy czynnik ochronny.

STABILNA RUTYNA

Te same pory posiłków, snu, szkoły. Stała godzina kolacji. *Przewidywalność* wewnętrzna obniża chroniczny lęk — daje dziecku punkty oparcia, których brakuje w nieprzewidywalnym domu.

PRZESTRZEŃ BYCIA DZIECKIEM

Zabawa, sport, przyjaźnie, hobby. Czas, w którym *nie trzeba* być odpowiedzialnym za dorosłych. Zwykłe rzeczy: trening, kółko zainteresowań, weekendy u dziadków.

PSYCHOEDUKACJA DOSTOSOWANA

Język dziecka, prosto: „*Tata choruje. To nie jest Twoja wina. Nie możesz tego naprawić. Możesz być po prostu dzieckiem.*” Krótko, kilkakrotnie, bez przeciążania.

04 Mój plan ochrony dziecka

BEZPIECZNY DOROSŁY DLA MOJEGO DZIECKA

— *kto już jest lub kogo chcę zaprosić*

STAŁA RUTYNA, KTÓRĄ CHRONIĘ

— *posiłki, sen, szkoła, weekendy*

JEDNO ZDANIE, KTÓRE CHCĘ POWIEDZIEĆ DZIECKU O PICIU RODZICA

— *dostosowane do wieku, krótko, bez obwiniania drugiego rodzica*

PROFESJONALNE WSPARCIE DLA DZIECKA

— *pedagog szkolny, psycholog dziecięcy, grupa wsparcia*

Klucz: Najczęstszy mit: „*dzieci nic nie widzą, bo są małe*”. W rzeczywistości *dzieci widzą wszystko* — często z większą czułością niż dorośli, bo od ich umiejętności czytania nastroju rodzica zależy ich bezpieczeństwo. Nie chronisz dziecka *przed wiedzą* — wiedza już tam jest. Chronisz *przed poczuciem winy* („*to przeze mnie pije*”), *przed parentyfikacją* i *przed samotnością*. *Werner & Smith* (2001): „*Jedna stabilna relacja z dorosłym była warta więcej niż wszystkie pozostałe czynniki łącznie.*”